

TEMA 3.8 • ENDOCRINOLOGÍA

Hipotiroidismo en el Embarazo

PERFIL EUNACOM 1.03.1.006
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome de Cushing

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Síndrome de Cushing ≠ Enfermedad de Cushing. - Síndrome de Cushing = hiper cortisolismo de cualquier causa - Enfermedad de Cushing = tumor hipofisario productor de ACTH (una de las causas del síndrome)

Causas (de más a menos frecuente)

- Corticoides exógenos (iatrógeno — la más frecuente de todas)
- Enfermedad de Cushing (tumor hipofisario productor de ACTH)
- Adenoma suprarrenal (tumor suprarrenal hiperproductor de cortisol)
- Hiperplasia suprarrenal
- Síndrome de ACTH ectópica (cáncer de pulmón de células pequeñas que produce ACTH)

Clínica

TABLA 3.8.1: SÍNTOMA / SIGNO VS NOTA		
SÍNTOMA / SIGNO	NOTA	
Astenia	Más frecuente (pero inespecífico)	
Obesidad centripeta	Abdomen, espalda alta ("búfalo"), cara de luna	
Estrías violáceas	Color vino tinto, anchas (> 1 cm)	
Atrofia muscular	Extremidades delgadas con tronco obeso	
Hipertensión secundaria	Por exceso de aldosterona y/o cortisol	
Diabetes	Por efecto antiinsulínico del cortisol	
Osteoporosis	Riesgo de Fracturas: Generalidades	fracturas
Hirsutismo en mujeres	Por andrógenos adrenales	
Infecciones	Inmunosupresión → primera causa de muerte	

Exámenes alterados

- Hipocalemia (K bajo)
- Hiperglicemia (o diabetes)
- Alcalosis metabólica (lo contrario a la insuficiencia suprarrenal)

Diagnóstico — 3 Pasos

Paso 1: Confirmar hiper cortisolismo (cualquiera de los 3)

TABLA 3.8.2: EXAMEN VS RESULTADO ANORMAL	
EXAMEN	RESULTADO ANORMAL
Cortisol libre en orina de 24 h	↑
Cortisol en saliva nocturna	↑
Prueba de supresión corta con dexametasona	Cortisol no suprime al dar 1 mg de dexametasona

→ Si 2 exámenes alterados (o 1 muy alterado) → confirma hiper cortisolismo → ir al paso 2

Paso 2: Localizar la causa — ACTH y prueba de supresión larga

TABLA 3.8.3: ACTH VS PRUEBA SUPRESIÓN LARGA		
ACTH	PRUEBA SUPRESIÓN LARGA	CAUSA
↑	Suprime	Enfermedad de Cushing (hipofisaria)
↑	No suprime	ACTH ectópica (cáncer de pulmón)
↓	No suprime	Suprarrenal (adenoma / hiperplasia)

Paso 3: Imágenes para localizar el tumor

TABLA 3.8.4: SOSPECHA VS IMAGEN	
SOSPECHA	IMAGEN
Causa hipofisaria	RNM de hipófisis
Causa suprarrenal	TAC/RNM de suprarrenales
ACTH ectópica	Rx de tórax → TAC de tórax (buscar tumor pulmonar)

Tratamiento

TABLA 3.8.5: CAUSA VS TRATAMIENTO	
CAUSA	TRATAMIENTO
Corticoides exógenos	Reducir dosis gradualmente
Enfermedad de Cushing	Cirugía (adenomectomía hipofisaria)
Adenoma suprarrenal	Cirugía (suprarrenalectomía unilateral)
Hiperplasia suprarrenal bilateral	Cirugía bilateral + sustitución con hidrocortisona + fludrocortisona

| ACTH ectópica | Tratar el tumor primario |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Embarazada de 8 semanas con TSH 5,2 mU/L y T4 libre 0,9 ng/dL (normal). ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipotiroidismo en el Embarazo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Screening con TSH a todas las embarazadas. Objetivo: TSH 0,4-2,5 (más estricto que 0,4-4).
- TSH >4 + T4 libre normal en embarazo = subclínico → tratar sí o sí (riesgo de daño neurológico fetal).
- TSH 2,6-4 en embarazo = zona gris, discutible si tratar o no.
- Hipotiroidismo previo + embarazo: aumentar dosis en 30% y ajustar para TSH <2,5.
- Las hormonas tiroideas son relativamente seguras en el embarazo.
- El riesgo de daño cerebral fetal justifica ser más agresivo en el control tiroideo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO)

PREGUNTA 1

Embarazada de 8 semanas con TSH 5,2 mU/L y T4 libre 0,9 ng/dL (normal). ¿Cuál es la conducta?

- A)** Observar, TSH casi normal
- B)** Iniciar levotiroxina
- C)** Repetir exámenes en segundo trimestre
- D)** Solicitar anticuerpos anti-TPO antes de decidir
- E)** Derivar a endocrinología sin tratar

RESUMEN: HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO

El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto. Se hace screening con TSH a todas las embarazadas. El objetivo de TSH es más estricto: 0,4-2,5 (no 0,4-4). Los requerimientos de hormonas tiroideas aumentan durante el embarazo. Interpretación del screening: TSH <2,5 + T4 libre normal = embarazo sano, observar. TSH 2,6-4 + T4 libre normal = zona gris, discutible si tratar. TSH >4 + T4 libre normal = subclínico, tratar sí o sí. TSH >4 + T4 libre baja = hipotiroidismo franco, tratar con levotiroxina. Si tiene diagnóstico previo de hipotiroidismo y se embaraza: aumentar dosis en 30% y ajustar para TSH entre 0,4-2,5.